甲状旁腺激素校准品说明书

【产品名称】
通用名称：甲状旁腺激素校准品
英文名称：Access Intact PTH Calibrators

【包装规格】
甲状旁腺激素复溶缓冲液（RB）：4.0mL/瓶×2瓶，校准品0（S0）：1.0mL/瓶，校准品1（S1）：1.0mL/瓶，校准品2（S2）：1.0mL/瓶，校准品3（S3）：1.0mL/瓶，校准品4（S4）：1.0mL/瓶，校准品5（S5）：1.0mL/瓶。

【预期用途】
本产品用于甲状旁腺激素测定时的校准。
Access Intact PTH Calibrators是用于校准Access Intact PTH测定，以通过使用Access免疫测定系统定量测定人血清和血浆中的完整型甲状旁腺激素（甲状旁腺素，PTH）水平。

【检验原理】
定量测定的校准是一个如同测试病人样本那样，对已知分析物浓度的样本(如，测定的校准品)进行测试以计算其反应值的过程。测得的反应值与已知分析物浓度之间的数学关系，可用于确立校准曲线。此数学关系，或校准曲线，用于将病人样本的RLU(光量子值)测定值转换为特定的定量分析物浓度。

【主要组成成分】
甲状旁腺激素复溶缓冲液（RB）：缓冲蛋白(牛)基质、0.5% ProClin 300；
校准品 0（S0）：磷酸盐缓冲液（PBS）、牛血清白蛋白(BSA)、表面活性剂、<0.1%叠氮钠；
校准品 1（S1）、校准品 2（S2）、校准品 3（S3）、校准品 4（S4）、校准品 5（S5）：水平分别大约为 10、60、300、1500 和 3500 pg/mL (1.1、6.4、31.8、159.0 和 371.0 pmol/L) 的甲状旁腺素(合成抗原)溶于磷酸盐缓冲液(含牛血清白蛋白、表面活性剂和<0.1% 叠氮钠)；
校准卡：2。

校准卡：对于 Access 完整型甲状旁腺素测定，一张校准卡是用于常规模式另一张卡是用于术中模式。
可用于常规模式和术中模式。
每支校准品用 1.0mL 的复溶缓冲液复溶。需要 30 分钟溶解完全。使用前请混匀。
参考校准卡以获得准确的浓度值。

溯源性

Access甲状旁腺激素校准品内的分析物，可溯源至生产商的工作用校准品。溯源性的建立过程是按EN ISO 17511进行的。
如用样本稀释液A来稀释WHO标准物质79/500，其平均回收率在该测定的全部范围内常规模式为57%，术中模式为53%。

【储存条件及有效期】
2~10℃竖直存放，有效期为 12 个月。
校准品和复溶缓冲液(RB)只能单次使用。
S0-S5 校准品为冻干形式。
复溶校准品如存储在18~25°C环境下，应在2小时内使用。
复溶校准品如存储在2~10°C环境下，应在10小时内使用。
冻干校准品和PTH复溶缓冲液(RB)在2~10°C下可稳定保存至效期末。
生产日期和失效日期见包装标签。

【适用仪器】
Access2、UniCel DxI 600 Access、UniCel DxI 800 Access。

【检验方法】
1. 参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，获取有关校准原理、设置校准品系列、校准品测试申请的输入和评论校准数据的信息。
2. Access Intact PTH测定的常规模式和术中模式都需要各自的校准卡。每一个模式都有各自的校准卡，并且必须按照相应的校准卡对它们进行校准。两个模式可用相同的校准卡。
3. Access甲状旁腺激素校准品提供的是6种浓度 ：零和大约10、60、300、1500 和3500 pg/mL (1.1、6.4、31.8、159.0 和371.0 pmol/L)。测定校准数据的有效期长达28天。校准品的测定应做双份。
4. 每瓶校准品用1.0 mL PTH 复溶缓冲液进行容量复溶。溶化30分钟。使用前轻轻混匀。

【检验方法的局限性】
与Access免疫测定系统及配套试剂使用。
方法的局限性试剂内如有微生物污染的迹象或显著浑浊，应弃去。

【注意事项】
• 供体外诊断使用。
• 按所描述的步骤进行操作，可使日常处理病人样本和血制品中所带来的风险降到最低。然而，无论这些产品的来源、处理方式或先前获得的证明，使用这些具有潜在传染性的物品均须按统一的注意事项和完善的临床实验室操作规范来进行。应使用合适的消毒剂来消除污染。遵循当地的操作规章和导则来保存并处理这些物品以及盛放这些物品的容器。
• 叠氮钠可能会与铅以及铜制的管件发生反应，形成具有高危爆炸性的金属叠氮物。在倾弃这种液体时，应以大量的水进行冲洗，防止叠氮物的集结。[7]
• Xi.刺激物：0.5% ProClin 300。

R 43：如接触皮肤可引起致敏作用。
S 28-37 ：接触到皮肤后应立即用大量肥皂和水清洗。应戴适用的手套。

• 材料安全数据资料 (MSDS) 可按需索取。

【标识的解释】

制造商

欧盟授权代表

生产日期

批次代码

产品编号

温度极限

温度上限

温度下限

体外诊断医疗器械

警告

阴性对照

阳性对照

有效期

生物风险

含量足够测试<n>次

查阅使用说明

怕晒

【参考文献】

1 Mundy GR, Guise TA. Hormonal control of calcium homeostasis. Clin Chem 1999; 45: 1347–1352.
2 Strewler GJ. Mineral metabolism and metabolic bone disease. In Basic and Clinical Endocrinology Fifth Edition;Greenspan FS & Strewler GJ Eds, 1997; 263–316.
3 K/DOKI guidelines for the management of renal osteodystrophy. Am J Kidney Dis 2003; 42(Suppl 3): S1–201.
4 Boggs JE, Irvin GL, Molinari AS, Deriso GT. Intraoperative parathyroid hormone monitoring as an adjunct to parathyroidectomy. Surgery 1996; 120: 954–958.
5 Clary BM, Garner SC, Leight GS. Intraoperative parathyroid hormone monitoring as an adjunct to parathyroidectomy for secondary hyperparathyroidism. Surgery1997; 122: 1034–1039.
6 Laboratory Guidelines for Evidence-Based Practice for POCT, final draft. August 2006. National Academy of Clinical Biochemistry.
7 DHHS (NIOSH) Publication No. 78–127, August 1976. Current Intelligence Bulletin

13 - Explosive Azide Hazard. Available http://www.cdc.gov/niosh.
8 Approved Guideline – Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens, H18-A2. 1999. National Committee for Clinical Laboratory Standards.
9 Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC & QA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989.
10 Kricka, L. Interferences in immunoassays – still a threat. Clin Chem 2000; 46: 1037.
11 Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: 613–621.
12 Souberbielle JC, Fayol V, Sault C, Lawson-Body E, et al. Assay specific decision limits for two new automated parathyroid hormones and 25-hydroxyvitamin D assays. Clin Chem 2006; 51: 395–400.
13 Approved Guideline – Statistical Quality Control for Quantitative Measurements: Principles and Definitions, C24-A2. February 1999. National Committee for Clinical Laboratory Standards.
14 Spencer CA, Takeuchi M, Kazarosyan M, MacKenzie F et al. Interlaboratory/intermethod differences in functional sensitivity of immunometric assays of Thyrotropin (TSH) and impact on reliability measurement of subnormal concentrations of TSH. Clin Chem 1995; 41: 367–374.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：Beckman Coulter, Inc. 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司

住所：250 South Kraemer Blvd., Brea, CA 92821, USA;
1000 Lake Hazeltine Drive Chaska, MN 55318, USA

生产地址：130 Avenue de Lattre de Tassigny BP 177, 13276 Marseille, Cedex 9 France

联系方式： 001-800-742-2345

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：021-38651000, 4008855355

代理人名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号 3 层 01 单元

联系方式：021-38651000, 4008855355

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

国械注进20142405468

【说明书核准日期及修改日期】

2024-03-15